

Quand les signes précoces ne suffisent pas : comprendre l'angle mort médical de la SEP

Maladie neurologique inflammatoire touchant environ 110 000 personnes en France, la sclérose en plaques (SEP) débute souvent par des symptômes discrets et intermittents. Cette ambiguïté entraîne fréquemment des retards de diagnostic, aux conséquences durables pour les patients.



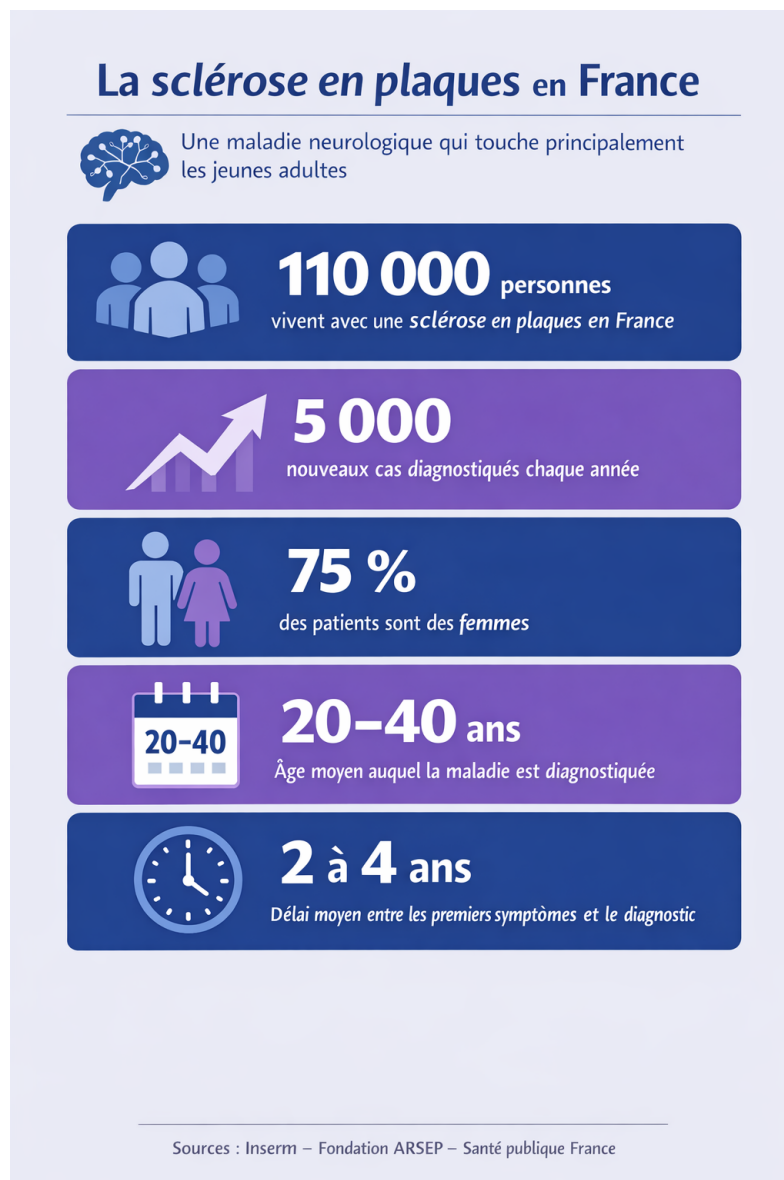
IRM du rachis cervical de Mélodie Dupouy. ©Mélodie Dupouy

Lorsque Melodie Dupouy ressent en 2021 son premier « choc électrique » dans la jambe droite sous l'eau froide de la douche, elle consulte immédiatement. À l'hôpital, le diagnostic tombe : sciatique, traitement anti-inflammatoire, retour à domicile. Mais la sensation revient, plus diffuse, plus dérangeante encore. Puis viennent les fourmillements dans les doigts, qui remontent jusqu'à l'aisselle en quelques jours. On suspecte alors une anémie, puis un canal carpien. « *J'ai vu trois généralistes, un radiologue et une neurologue avant qu'on évoque la [SEP](#)* », raconte-t-elle.

Bien avant elle, Anne-Marie Desrumeaux a connu une errance encore plus longue. Diagnostiquée à 23 ans en 1996, elle décrit une première poussée brutale : fatigue extrême, troubles de la parole, impossibilité de marcher. Hospitalisée deux semaines, elle enchaîne les examens sans réponse claire. « *On ne savait pas, on attendait* », se souvient-elle. Le diagnostic ne sera posé que cinq ans plus tard, après une seconde poussée. Entre-temps, la maladie évolue silencieusement. Ce parcours n'a rien d'exceptionnel.

Les symptômes initiaux de la SEP, paresthésies*, troubles visuels, vertiges, sont des motifs de consultation extrêmement fréquents. Dans près de 80 % des cas, la maladie débute par des signes neurologiques transitoires, souvent réversibles, ce qui complique leur interprétation. Le Dr Philippe Walter, généraliste, rappelle ainsi que ces signes sont « *souvent banals, non spécifiques d'une maladie* », et qu'on ne peut demander « *des IRM pour tout et n'importe quoi* ». La difficulté réside dans ce seuil flou : quand un picotement est-il juste un picotement et quand devient-il un signal neurologique ?

Melodie, elle, se heurte à un second obstacle : la perception extérieure. « *Même mes proches me disaient que c'était dans ma tête* », explique-t-elle. Tant que rien n'est confirmé médicalement, la plainte corporelle reste suspecte. Ce doute social s'ajoute au doute médical, isolant le patient dans un entre-deux anxieux : quelque chose ne va pas mais rien n'est encore prouvé.



Les failles d'un système qui ne regarde pas assez vite au bon endroit

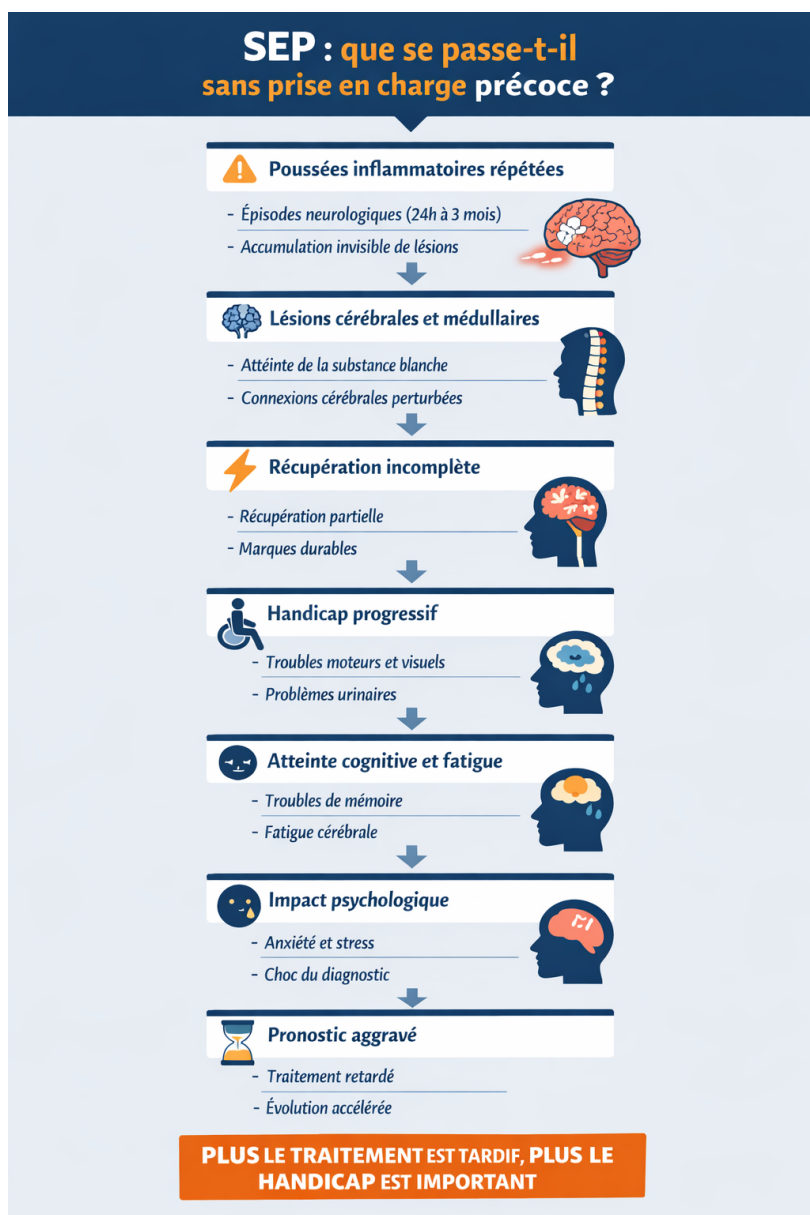
Après des mois d'errance, c'est une IRM médullaire* prescrite en août 2025 qui marque enfin un tournant. L'image révèle une inflammation dans la moelle épinière. « *C'est à ce moment-là que je me suis sentie enfin prise au sérieux* », confie Melodie. Une seconde IRM cérébrale met alors en

lumière des lésions anciennes, passées inaperçues lors de précédentes poussées. La ponction lombaire achève de confirmer le diagnostic : sclérose en plaques.

Ce scénario est connu des neurologues. Le [Dr Philippe Meynieux](#) explique que la maladie « *peut débuter sans signe clinique évident* » et que certaines premières poussées sont si courtes, parfois 48 heures, que le patient ne s'en souvient pas. Il arrive aussi que la SEP soit découverte par hasard : « *Une IRM faite pour une autre raison peut révéler des lésions évocatrices* ». Cette difficulté à dater précisément le début de la maladie est bien documentée : certaines lésions peuvent être anciennes de plusieurs années au moment du diagnostic.

Si l'on sait aujourd'hui traiter plus tôt et plus efficacement qu'il y a vingt ans, encore faut-il repérer la maladie. Or les études montrent que l'instauration précoce des traitements permet de réduire significativement la fréquence des poussées et de ralentir l'accumulation du handicap. Or, le goulot d'étranglement se situe au niveau du tri initial : entre généraliste et neurologue. Le Dr Walter souligne un frein pratique majeur : « *les délais de rendez-vous sont très clairement un problème* ». On peut attendre jusqu'à six mois pour une consultation spécialisée, parfois davantage dans certains territoires. Le symptôme, lui, peut avoir disparu depuis longtemps, effaçant la preuve.

À cela s'ajoute une réalité économique rarement évoquée publiquement : demander des IRM systématiques serait socialement coûteux pour une maladie statistiquement peu fréquente. Contrairement au dépistage du cancer du sein ou du côlon, la SEP ne bénéficie pas d'un [programme national de screening*](#). Elle frappe surtout les jeunes adultes mais pas en volume suffisant pour déclencher une politique de masse.



Quand le corps attend, le cerveau s'abîme et la vie bascule

Le retard de diagnostic n'est pas qu'un chiffre, il a un effet profond sur les trajectoires de vie. Chaque poussée inflammatoire peut laisser une empreinte irréversible sur le système nerveux. La maladie touche la substance blanche du cerveau, altérant les connexions entre différentes zones, ce qui explique la diversité des symptômes.

Melodie raconte : « *Le plus handicapant, c'était ma main. Je ne pouvais plus tenir un stylo, j'avais l'impression qu'elle ne répondait plus.* » Au-delà du moteur, la fatigue neurologique s'installe.

Penser, se concentrer, mémoriser demande une énergie disproportionnée.

L'impact psychologique est tout aussi tangible. Melodie décrit « *un stress permanent en attendant le diagnostic* ». Comme beaucoup de patients, elle oscille entre la peur de la maladie et la peur de l'absence d'explication.

Chez les cas diagnostiqués plus tard, l'effet est encore plus marqué. Anne-Marie Desrumeaux raconte avoir vécu plusieurs mois sans pouvoir marcher ni parler correctement lors de sa première poussée sévère, avant qu'on évoque une crise d'épilepsie. Le diagnostic de SEP n'a été posé que cinq ans plus tard, après une seconde poussée. « *On ne savait pas, on attendait, et j'ai passé deux semaines à l'hôpital sans rien comprendre* », se souvient-elle.

Ce temps perdu est aussi un temps émotionnel. Anne-Marie confie : « *Le choc a été terrible. J'ai mis des mois à m'en remettre.* » L'annonce du diagnostic ne soulage pas toujours, elle fixe l'irréversible.



Centre de référence régional, le CHR de Lille suit plus d'un millier de patients atteints de sclérose en plaques, mais comme souvent, le nombre de nouveaux cas diagnostiqués chaque année n'est pas communiqué.

©Association du Musée Hospitalier Régional de Lille

Vers une médecine plus attentive : former, écouter, anticiper

Pour éviter ces retards, plusieurs pistes émergent. La première est triviale en apparence : écouter attentivement le patient. Le Dr Meynieux insiste : « *Si le patient décrit bien ses symptômes, et qu'ils sont évocateurs d'un problème neurologique, le diagnostic devient plus facile.* » Melodie abonde : « *Il faut aller au bout de l'exploration, ne pas minimiser, ne pas renvoyer quelqu'un chez lui avec du Doliprane.* »

La seconde piste est structurelle : former davantage les généralistes à repérer des symptômes banals mais répétés. Car ce n'est pas la brièveté d'un trouble qui importe mais sa récurrence. Enfin, la technologie ouvre une voie prometteuse. Au [CHR de Lille](#), des modèles d'intelligence artificielle sont déjà testés pour « pointer » automatiquement des anomalies suspectes dans les IRM. Ces outils, encore en phase de recherche, analysent les images médicales en détectant des variations de signal dans la substance blanche, parfois difficilement visibles à l'œil humain. L'IA agit comme un système d'alerte, orientant le regard du radiologue vers des zones potentiellement pathologiques.

L'IA ne remplace pas l'expertise humaine, mais augmente la vigilance diagnostique. « *Il y aura toujours une interprétation humaine* », rappelle le Dr Meynieux, « *mais l'IA aidera à ne pas passer à côté.* »

À terme, ces technologies pourraient permettre de réduire les erreurs d'interprétation et d'accélérer les diagnostics, notamment dans les phases précoces de la maladie.

Ce que demandent les patients n'est pas une médecine omnisciente mais une médecine capable de reconnaître l'incertitude et d'approfondir le doute. Dans une pathologie où les signes sont discrets et fluctuants, la rapidité du diagnostic repose autant sur les outils que sur l'attention portée aux premiers symptômes.

Charlotte Esteve

Définitions

- **Paresthésies** : sensations anormales sur la peau, comme des picotements, fourmillements ou engourdissements.
- **Médullaire** : qui concerne la moelle épinière (la partie du système nerveux dans la colonne vertébrale).
- **Screening** : dépistage, c'est-à-dire rechercher une maladie chez une personne avant même qu'elle ait des symptômes.

Chiffres clés

- 110 000 personnes vivent avec une SEP en France
- 5 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année
- 20–40 ans : âge moyen des premiers symptômes
- 1 à 3 ans : délai moyen de diagnostic selon les études
- Jusqu'à 6 mois d'attente pour consulter un neurologue

Je connaissais déjà l'existence de la sclérose en plaques avant de commencer cette enquête, mais c'est le diagnostic d'une amie en septembre 2025 qui m'a poussée à m'y intéresser. Son parcours, marqué par des symptômes d'abord minimisés puis par de nombreuses consultations avant d'obtenir une réponse claire, m'a interpellée.

En en parlant autour de moi et en me documentant, j'ai rapidement constaté que ce type de parcours n'était pas isolé. Les retards de diagnostic semblent fréquents, en raison de symptômes souvent banals et difficiles à interpréter au début.

Ce qui m'a surtout frappée, c'est le décalage entre les discours médicaux et les témoignages de patients.

L'IRM est présentée comme l'examen clé pour confirmer la sclérose en plaques, mais dans les faits, elle n'est prescrite que lorsqu'une suspicion suffisamment forte existe déjà. Cela crée une forme de cercle paradoxal : l'outil indispensable au diagnostic n'est utilisé qu'après plusieurs autres hypothèses.

Pour comprendre ce décalage, j'ai recueilli plusieurs témoignages : celui de Mélodie, d'un neurologue, d'un médecin généraliste que je connais, et de la mère d'un camarade de classe concernée par la maladie. Ces échanges m'ont montré des points de vue différents selon les rôles dans le parcours de soins, entre contrainte médicale et vécu des patients. Cette enquête est née de ce tiraillement entre un système de santé qui dispose d'outils efficaces, et des patients qui décrivent encore une attente longue avant d'obtenir un diagnostic.

J'aurais écrit cette enquête pour Mediapart (version santé/société).